Couveuse en babykamer HagaZiekenhuis Zoetermeer

Wij willen de contacten tussen u, uw kind en de afdeling zo prettig mogelijk laten verlopen.
Om u een beetje houvast te bieden tijdens het verblijf van uw kind op de kinderafdeling, willen wij u graag wat meer vertellen over de afdeling en de dagelijkse gang van zaken.

Het lezen van deze informatie zal waarschijnlijk op veel van uw vragen een antwoord geven, maar wellicht ook nieuwe vragen bij u oproepen. Stel deze gerust als er iets niet helemaal duidelijk is.

Wij hopen op een goede samenwerking gedurende de periode dat uw kind op onze afdeling wordt verpleegd.

De kinderafdeling is bereikbaar via telefoonnummer: (079) 346 21 08.

Algemeen

De kinderafdeling is in twee units verdeeld en biedt plaats aan 24 kinderen van 0 tot 16 jaar.

De unit 0 t/m 4 jaar beschikt over zes couveuses, verdeeld over twee kamers. De wiegjes zijn in principe op een andere kamer te plaatsen. Deze babykamer is wat koeler dan de couveusekamers, zodat de kinderen kunnen wennen aan de temperatuur van thuis.

Of uw kind bij de opname in een wieg of couveuse terechtkomt is van veel punten afhankelijk, zoals gewicht, leeftijd en de gezondheidstoestand. In de meeste gevallen zal uw kind in eerste instantie in de couveuse worden opgenomen. Hoelang uw kind in de couveuse blijft, is afhankelijk van bijvoorbeeld groei, temperatuur en de gezondheidstoestand.

Wij werken met en in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Identificatieplicht

In het kader van de wettelijke identificatieplicht verzoeken wij u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Voor een kind onder de 14 jaar is een geldig identiteitsbewijs van de ouder/verzorger voldoende. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van het ziekenhuisdossier en de verzekeringsgegevens. Wilt u ook uw verzekeringspasje meenemen?

Verpleegkundige zorg

Op onze afdeling werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Ook werken er verpleegkundigen in opleiding.

Wij streven naar ‘patiëntgericht verplegen’, wat inhoudt dat wij het aantal verschillende gezichten rond het bed van uw kind zoveel mogelijk proberen te beperken. Door de wisselende diensten zal het voorkomen dat u en uw kind met verschillende verpleegkundigen te maken krijgen, die elkaar op de hoogte houden over uw kind. Op het bord bij de medicatie bereidingsruimte ziet u de naam van uw kind, het kamernummer en de naam en foto van de verpleegkundige die, die dag voor uw kind zorgt.

Tevens vindt u op dit bord de andere medewerkers die, die dag aanwezig zijn.

Voor inlichtingen over uw kind kunt u terecht bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Overigens worden deze inlichtingen alleen aan de ouder(s) van het kind gegeven.

Als uw kind hier langer dan zeven dagen verblijft, krijgt u een vaste verpleegkundige (eerst-verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) toegewezen, die eenmaal per week de gang van zaken met u evalueert.

Medische zorg

Er zijn meerdere kinderartsen verbonden aan de kinderafdeling. Als uw baby op afdeling 1b ligt, kunt u hierbij aanwezig zijn, de visite vindt plaats tussen 9.30 en 11.30 uur.

Alle veranderingen in de zorg of behandeling van uw baby worden dan met u doorgesproken .

Indien uw kind stabiel is en er geen veranderingen zijn loopt in het weekend de kinderarts geen visite over uw kind

Vragen kunt u altijd via een verpleegkundige aan de artsen doorgeven. Hebt u behoefte aan een gesprek met de kinderarts, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Deze zal een afspraak voor u maken.

Als uw kind hier langer dan zeven dagen verblijft dan krijgt u een vaste kinderarts toegewezen, die eenmaal per week de gang van zaken met u evalueert.

Arts-assistent

Dit is een basisarts (afgestudeerde arts) die in afwachting van een eventuele opleidingsplek voor specialisatie, ervaring opdoet op de kinderafdeling. Hij/zij is hier minimaal één jaar.

Hij/zij ziet u en uw kind in principe dagelijks en is op de hoogte van de medische zorg die uw kind nodig heeft. Hij/zij werkt onder toezicht van de kinderarts en deze is de hoofdbehandelaar. Hij/zij loopt visite en houdt oudergesprekken. Ook doet hij/zij eenmaal per week spreekuur op de polikliniek.

Overige medewerkers

- Er zijn nog andere ziekenhuismedewerkers die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op onze afdeling:
- De pedagogisch medewerker: Deze is maandag tot en met vrijdag aanwezig op de kinderafdeling. De pedagogisch medewerker heeft als taak kind en ouders gedurende de ziekenhuisopname te begeleiden. Indien u het prettig vindt eens met haar te praten, dan kunt u dit met de verpleegkundige of kinderarts bespreken.
- De Nurse Practitioner: Dit is een verpleegkundig specialist.
- De coassistenten: dit zijn aankomende artsen die bezig zijn met het laatste deel van hun studie.
- De kinderfysiotherapeut: Deze komt twee keer per week op de afdeling en ziet alle prematuren. Ze beoordeelt de motoriek van de baby's en kan vragen beantwoorden op het gebied van de motorische ontwikkeling. Samen met de verpleging wordt bekeken en bijgehouden hoe uw kindje reageert op de verzorging, de houding in bed enz. Zonodig worden aanpassingen aangebracht. Verder kan zij adviezen geven voor thuis. Indien nodig wordt de kinderfysiotherapie thuis voortgezet.

- De afdelingssecretaresse: Deze zit achter de balie in de hal en regelt de administratieve zaken van onze afdeling.
- De logopedist: Deze wordt ingeschakeld wanneer uw kind moeilijkheden heeft met bijvoorbeeld zuigen of slikken.
- De psycholoog: Deze wordt ingeschakeld bij psychologische problemen.
- De gastvrouw: Deze zorgt voor het eten en drinken.
- De afdelingsassistente: Deze ondersteunt de verpleging met logistieke zaken op de afdeling.
- De interieurverzorgster: Deze zorgt voor het schoonhouden van de afdeling.

Afdelingsregels

- Op de couveuse- en babyunit gelden enkele specifieke afdelingsregels:
- Uw jas hangt u op aan de daarvoor bestemde haakjes op de gang.
- Handhygiëne:
  - Na binnenkomst horloges, ringen en armbaden verwijderen
  - De handen reinigen met twee pompjes handenalcohol
  - 30 Seconden inwrijven en aan de lucht laten drogen
  - Handen met water en zeep wassen:
    - Bij zichtbare verontreiniging
    - Bij plakkerig aanvoelen
    - Na toiletbezoek
    - Na snuiten, niezen of hoesten
    - Na nuttigen van etenswaren
    - Na roken

Hierna geen handenalcohol gebruiken.

- Wanneer u, als ouder(s), verkouden bent of een andere besmettelijke ziekte hebt, meld dit dan bij de verpleegkundige. Deze kan u vertellen of u de babykamer kunt betreden en welke maatregelen u moet nemen.
- Het is niet toegestaan om op de andere babykamers te komen, tenzij de verpleegkundige u toestemming geeft.
- Zet u, i.v.m. rust en mogelijke storing van de apparatuur, uw mobiele telefoon uit op de couveusekamer.
- Op onze afdeling staat bij de afdelingskeuken een koffieapparaat, en u kunt daar ook thee en/of limonade pakken. Deze service is alleen bestemd voor ouders.

Aangifte

U kunt de geboorte aangifte online doen: https://www.zoetermeer.nl/geboorteaangifte

Bezoek

Ouders zijn de hele dag welkom. Wij gunnen de kinderen tussen de voedingstijden zoveel mogelijk rust, daarom vragen wij aan u om uw kind niet in zijn slaap te storen.

Voor ouders en bezoekers gelden, naast de afdelingsregels, de volgende regels:

- Bezoek mag alleen naar binnen als één van de ouders aanwezig is.
- Broertjes en/of zusjes zijn welkom, mits in gezelschap van één van de ouders tot 19.30uur. Dit kan echter niet als ze verkouden zijn of recentelijk contact hebben gehad met een kinderziekte.
- Bezoek broertjes en/of zusjes bij verdenking waterpokken:
    - Broertjes/zusjes hebben geen waterpokken gehad en wel contact met waterpokken (< 3 weken) NIET naar binnen
    - Broertjes/zusjes hebben wel waterpokken gehad, wel naar binnen
    - Broertjes/zusjes hebben geen waterpokken gehad, en geen recentelijk (< 3 weken) contact, wel naar binnen
    - Neemt u bij twijfel contact op met de verpleegkundige die uw kind verzorgt;
- Denk eraan dat u uw kind niet rustig kunt verzorgen als uw oudste kind zonder toezicht rondloopt.
- Tijdens bezoektijd (15.30 - 19.30 uur) mogen maximaal twee personen op bezoek komen, om de rust van de kinderen te waarborgen en om de kans op infectie te verminderen. Er moet altijd 1 ouder aanwezig zijn bij bezoek.
- Wij vragen u om bezoek tijdens een voedingsmoment zoveel mogelijk te vermijden zodat u uw volledige aandacht op uw kindje kunt richten. Daarnaast willen wij u vragen om rekening te houden met de hoeveelheid geluid (geen muziek/filmpjes) op de couveusekamers en telefoongesprekken zoveel mogelijk op de gang te voeren. Dit met het oog op het minimaliseren van prikkels voor de kinderen.
- Wij begrijpen dat het vaak voor opa en oma erg belangrijk is om hen kleinkind te zien, dus voor hun maken wij eenmalig een uitzondering om met zijn vieren te kijken.
- Bezoekers die luchtweg gerelateerde klachten hebben en/of verkouden of ziek zijn of in contact zijn geweest met (kinder-) ziekten (vooral met waterpokken), mogen in verband met eventuele besmetting niet op bezoek komen.
- Kinderen van bezoek mogen **niet** op de babykamers.

Dagelijkse verzorging van uw kind

Wij zijn de mening toegedaan dat het zowel voor u, als ouders, als voor uw kind belangrijk is dat u uw kind zoveel mogelijk zelf verzorgt. Uiteraard zullen wij u hierbij, zo nodig, ondersteunen. Afhankelijk van de conditie van uw kind en van uzelf, maakt u met de verpleegkundige afspraken over wanneer u komt en welke verzorging u geeft.

Bij de wieg/couveuse ligt een daglijst waarop we diverse handelingen mbt uw kind noteren. U mag hierop schrijven, hoe laat uw volgende bezoek aan uw kind is, zodat wij daar met de voeding/verzorging rekening mee kunnen houden.

Vooraf kunt u, als u dat zelfstandig lukt, uw kind verschonen, temperaturen en/of baden en wegen. Uw kind mag tijdens de opname eigen kleertjes dragen als de situatie dit toelaat. De verpleegkundige zal dit aangeven.

Apparatuur, bewaking en behandelingsmiddelen

Tijdens de opname maken wij gebruik van allerlei apparatuur om uw kind zo goed mogelijk te bewaken, observeren en verplegen. Het is niet toegestaan dat u zelf aan de apparatuur komt. Wilt u daarom de verpleegkundige roepen, wanneer u uw kind wilt verzorgen?

U kunt de hierna volgende apparaten tegenkomen.

Een met perspex overkapt bedje waarin uw kind voor observatie en temperatuurregeling ligt.

De monitor bewaakt de hartslag en de ademhaling. Dit gebeurt aan de hand van drie plakkers (polen) die op de borst en buik worden geplakt.

De zuurstofconcentratie in het bloed kan gemeten worden door een speciaal daarvoor bestemde meter die meestal aan de voet wordt bevestigd.

Via een infuus kan een kind worden voorzien van vocht, medicijnen of de zogeheten, intraveneuze voeding. Dit gebeurt door een flexibel kunststof buisje in een ader te leggen. De plaats waar dit infuus wordt ingebracht wisselt van handen, armen, benen tot in het hoofdje. Het infuus wordt vastgeplakt met pleisters en ondersteund door een spalkje, behalve als het infuus in een ader in het hoofd zit.

Een maagsonde is een doorgankelijk slangetje dat via de neus naar de maag gebracht wordt, zodat voeding of medicijnen gegeven kunnen worden. Het wordt ook gebruikt als uw kind nog niet sterk genoeg is om alle voeding zelfstandig te drinken.

Als er iets niet (helemaal) duidelijk is, kunt u gerust om uitleg vragen.

Op alle kamers is een belsysteem aanwezig, waarmee u de verpleegkundige kan waarschuwen/roepen. De kamers op de 0 t/m 4 jaar unit zijn eveneens voorzien van een intercom. De intercom zorgt ervoor dat, ook wanneer er niemand op de kamers aanwezig is, eventuele alarmen van de apparatuur duidelijk hoorbaar zijn. Tevens is er een centrale monitor op de zusterpost waar wij de monitoren en eventuele alarmen in de gaten kunnen houden. Hierdoor is een goede controle gewaarborgd.

Borstvoeding

U heeft waarschijnlijk zelf al een idee gevormd of u uw baby borstvoeding wilt geven.

In sommige situaties kunt u niet direct borstvoeding geven, te weten:

- uw kind kan door zijn/haar ziekte niet voldoende zelf drinken aan de borst.
- uw kind is te vroeg geboren om zelf aan de borst te drinken.
- u gebruikt medicijnen die schadelijk kunnen zijn voor uw kind.
- u kunt niet alle voedingstijden in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Het is in deze gevallen raadzaam om zo snel mogelijk met afkolven te beginnen, bij voorkeur binnen zes uur na de bevalling. Dit om de borstvoeding op gang te brengen. U kunt de voeding dan drie maanden in de vriezer bewaren.

Vraag naar onze patiënteninformatie over Borstvoeding en kolven .

Onderzoeken en medische ingrepen

Het kan zijn dat de arts een aantal onderzoeken bij uw kind wil doen. Uiteraard proberen wij u hier zo vroeg mogelijk en het liefst vooraf over in te lichten, dit lukt echter niet altijd. Van een aantal onderzoeken hebben wij een voorlichtingsfolder.

Mocht u geen voorlichtingsinformatie hebben ontvangen, vraagt u hier dan gerust naar.

De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, blijft bij uw kind tijdens het onderzoek.

Wij proberen ervoor te zorgen dat u ook zoveel mogelijk bij het onderzoek aanwezig kunt zijn, maar dit is niet altijd mogelijk. De uitslagen van de onderzoeken krijgt u van de afdelingsarts of kinderarts.

Sucrose als pijnbestrijder

Op de kinderafdeling geven wij sucrose (max. viermaal daags) als een premature of (zieke) pasgeborene een pijnlijke ingreep moet ondergaan.

Uit onderzoek is gebleken, dat uw kind veel minder pijn voelt als vlak voor bijv. de hielprik of het inbrengen van een infuus een kleine hoeveelheid sucrose in de wangzak van uw baby wordt gedaan.

Pijn

Voor pijnmeting bij kinderen 0 – 4 jaar maken wij gebruik van de comfortschaal. Verpleegkundigen observeren hierbij gedurende twee minuten uw kind op zes gedragskenmerken en afhankelijk van de uitslag wordt hierop actie ondernomen.

Hielprik

Iedere pasgeborene krijgt een hielprik welke 72 uur na de geboorte geprikt kan worden. Als uw kind nog in het ziekenhuis ligt, gebeurt het hier. Anders prikt de verloskundige uw kind thuis. Het bloed van de hielprik wordt onderzocht op 17 verschillende aandoeningen.

Er wordt aan u, voor het prikken, gevraagd of u wel/niet bezwaar heeft dat er een deel van het bloed gebruikt wordt voor medisch onderzoek. En of u wilt weten of uw kind drager is van een ziekte.

U ontvangt binnen 5 weken zelf uitslag van het onderzoek.

Vraag naar de bijbehorende folder en/of kijk op de site: https://www.pns.nl/hielprik

Verhuizen naar een andere kamer

Het kan gebeuren dat uw kind naar een andere kamer verhuist. Wij proberen dit tijdig aan te geven door u telefonisch te informeren en/of door het witte bord op tijd aan te passen.

Buidelen of kangoeroën is een manier om ouders en hun pasgeboren baby heel dicht bij elkaar te brengen. De methode is bedoeld om de voordelen van de beschikbare ziekenhuisvoorzieningen te

combineren met ouderlijke warmte en intimiteit, het huidcontact tussen kind en ouder bevordert de ouder-/kindrelatie.

Vooral couveusekinderen komen voor de kangoeroemethode in aanmerking, maar in principe kunnen alle pasgeborenen samen met hun ouders buidelen. Wij zullen al vrij snel na de bevalling het buidelen voorstellen. Wanneer de algemene conditie van uw kind nog niet goed is of wanneer uw kind ziek is, stellen wij het buidelen nog even uit.

Op de website www.care4neo.nl kunt u veel informatie vinden over couveusekinderen.

Baby in beeld

Wij bieden, via 'Baby in beeld', de mogelijkheid om kosteloos vanuit huis of een andere plaats videobeelden van uw kind te bekijken. De camera laat, via onze website, videobeelden zien van uw kind in de couveuse of wieg. De beelden zijn alleen te bekijken door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Video Interactie Begeleiding

Direct na de geboorte geven baby's al met verschillende houdingen en bewegingen aan, wat ze wel of niet prettig vinden. Dit noemen wij de lichaamstaal van de baby. De initiatieven van pasgeboren baby's zijn nog vluchtig, maar met video-opnamen worden als het ware deze momenten vergroot en wordt het mogelijk al in een vroeg stadium de baby te begrijpen.

Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker, die speciaal hiervoor is opgeleid, maakt een korte video-opname tijdens bijvoorbeeld de verzorging of het buidelen.

Zij bekijkt de video-opname samen met de ouders en laat aan de hand van deze beelden zien, welke contactsignalen de baby laat zien om in contact te komen of te blijven.

Het is voor ons helaas (nog) niet mogelijk iedereen deze vorm van begeleiding aan te bieden. Wellicht zult u door de kinderarts of verpleegkundige benaderd worden of u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning. U kunt er ook zelf naar vragen bij de kinderarts of verpleegkundige. Ook kunnen zij u meer informatie geven over deze methode.

Vraag naar onze patiënteninformatie over Video Interactie Begeleiding.

Speelkamer

De kinderafdeling beschikt over een speelkamer. Deze ruimte is **alleen** bestemd voor de kinderen die op de kinderafdeling zijn opgenomen. Helaas beschikken wij niet over een speelruimte voor broertjes en zusjes.

Ontslag en nazorg

De dag waarop uw kind wordt ontslagen uit het ziekenhuis, is vaak moeilijk te voorspellen. Wij streven ernaar u het tijdstip van vertrek tijdig mede te delen. De kinder- of afdelingsarts spreekt met u over een eventueel vervolg van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige houdt met u een ontslaggesprek.

Het is voor ons prettig te horen hoe u uw verblijf op onze afdeling heeft ervaren. Met behulp van uw op- en aanmerkingen kunnen wij onze verpleegkundige zorg verbeteren.

Er wordt door de afdelingssecretaresse zo nodig een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde gemaakt voor controle van uw kind. De polikliniek bevindt zich op de 2 e etage, routenummer 26. Uw huisarts en het consultatiebureau worden over de ziekenhuisopname van uw kind en de eventuele nazorg geïnformeerd.

Vragen en inlichtingen

Voor vragen en/of inlichtingen mag u te allen tijde contact opnemen met de kinderafdeling. De kinderafdeling is bereikbaar via telefoonnummer: (079) 346 21 08.

NB Inlichtingen worden alleen aan de ouder(s) van het kind gegeven.

Overige

U mag (1 x per week zelf te wassen) knuffels meenemen om in bedje of couveuse te leggen. Ook muziekdoosjes en tekeningen mag u ophangen.

U kunt ook gebruik maken van een 'geurdoekje'. U draagt een (schoon) doekje een poosje bij u en dan kunt u het bij uw kind in de couveuse/wieg leggen. Zo heeft uw kind toch uw geur bij zich. Wij vragen u vriendelijk om eenmaal per week de knuffels te wassen.

Dagboekje

Het is vaak maar beperkt mogelijk om bij uw kind te zijn en veranderingen mee te maken nu uw kind in het ziekenhuis ligt. Om toch zoveel mogelijk vast te houden van de eerste periode na de geboorte kunt u een schrift/dagboekje achterlaten bij uw kind. Zo kan iedereen af en toe een stukje schrijven voor en over uw kind.

Fopspeen

Een prematuur (te vroeg geboren baby) kan soms een speen nodig hebben om te leren zuigen en evt. als troost als ouders er niet zijn of de werking van de sucrose (zie kopje sucrose als pijnbestrijder) te versterken

Er zijn voor de prematuren baby's geen fopspenen te koop in de winkel.

Aan prematuren baby's die onder de 35 weken geboren zijn geven wij, met uw toestemming, eenmalig een prematuren fopspeen

Overleg van tevoren even met de verpleegkundige of u kind een prematuren fopspeen nodig heeft

Parkeerterrein en parkeergarage

U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats voor het ziekenhuis. Kijk voor de actuele parkeertarieven op de borden bij de betaalautomaat.
Verblijft uw kind langere tijd in het ziekenhuis, dan kan het voordelig zijn een weekkaart aan te schaffen.

Bekijk voor informatie over parkeren de website: www.hagaziekenhuis.nl.

Tot slot

Wij willen u, wellicht ten overvloede, op het hart drukken om niet met vragen of problemen rond te blijven lopen. Maak ze bespreekbaar!

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kindergeneeskunde. **079 3462107**

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

510222122025